

Van welvaart naar welstand

Waarom maximale arbeidsparticipatie niet hetzelfde is als maximale maatschappelijke welvaart

10 september 2026 - versie 0.1.0

Dit document is een scenarioverkenning. Het bevat geen voorspelling en bewijst geen causale relaties.

Samenvatting

Nederland stuurt sterk op hoge arbeidsparticipatie. Dat ondersteunt marktproductie en belastinginkomsten, maar beantwoordt niet vanzelf de vraag hoe schaarse tijd en arbeid het best worden verdeeld. Deze verkenning introduceert optimale arbeidsparticipatie: huishoudens moeten verschillende combinaties van betaalde arbeid, zorg en vrije tijd kunnen kiezen zonder dat minder betaalde arbeid direct onhoudbaar wordt.

De kernhypothese is dat een vrijwillige daling van betaalde arbeid bij een deel van de huishoudens ook de vraag naar uitbestede, arbeidsintensieve diensten kan verminderen. Het netto-effect op krapte is daarom niet per definitie gelijk aan het verloren arbeidsaanbod. Herallocatie naar zorg, onderwijs en techniek is mogelijk, maar niet automatisch.

1. De beleidsvraag

De combinatie van hoge participatie en structurele tekorten in onder meer zorg, onderwijs en techniek maakt arbeidsallocatie relevant. Niet ieder arbeidsuur is onderling uitwisselbaar: opleiding, locatie, beloning, werkdruk en voorkeuren bepalen waar arbeid terecht komt. Maximale arbeidsparticipatie is een middel, geen zelfstandig doel. Maatschappelijke welvaart omvat naast marktinkomen ook gezondheid, tijd, zorg, sociale relaties, woonkwaliteit en publieke voorzieningen.

2. Mechanisme

Een tweede inkomen kan extra vraag creëren naar kinderopvang, schoonmaak, bezorging, horeca, vervoer en andere tijdvervangende diensten. Wanneer huishoudens vrijwillig minder betaald werken, kan een deel van deze afgeleide vraag dalen. Daarom is het analytisch onjuist om iedere verdwenen arbeidsuur een-op-een als extra krapte te tellen.

3. Illustratieve scenarioanalyse 2026-2046

Het rekenvoorbeeld gebruikt 2,56 miljoen tweeverdienershuishoudens, een tweede arbeidsinzet van gemiddeld 24 uur per week en 48 werkweken. In de centrale illustratie gaat 40% van de bruto urenverschuiving samen met minder vraag naar arbeidsintensieve diensten. Dit zijn transparante aannames, geen feitelijke ramingen.

Scenario	Huishoudens	Bruto uren	Netto uren*	FTE
5%	128.000	147,5 mln	59,0 mln	32.400
10%	256.000	294,9 mln	118,0 mln	64.800
15%	384.000	442,4 mln	176,9 mln	97.200

* Bruto uren x 40% vraagreductie. FTE is berekend met 1.820 uur per jaar. Dit is geen aantal direct beschikbare verpleegkundigen, leraren of technici.

4. Welzijn, wonen en kinderen

Meer tijd kan de druk rond werk en zorg verminderen, maar minder inkomen of een ongelijke verdeling van zorg kan ook nadelig zijn. Een effect op mentale gezondheid is daarom niet ingevuld als zekerheid. Hetzelfde geldt voor kinderen: ouderlijke tijd, stress, inkomen, opvangkwaliteit en gezinscontext zijn met elkaar verweven.

Lagere maximale hypotheekruimte kan biedingsdruk dempen, maar aanbod, rente, grondprijzen, migratie en regionale verschillen blijven doorslaggevend. Een andere inkomensverdeling lost het woningtekort niet op. Meer tijd en voorspelbaarheid kunnen een rol spelen in gezinsvorming, maar veroorzaken niet automatisch meer geboorten.

5. Beleidsrichting

De verkenning bepleit geen dwang en geen standaardgezinsmodel. De relevante beleidsvraag is of huishoudens reële keuzeruimte hebben voor combinaties zoals 40+0, 32+16, 24+24 of 40+40 uur. Belastingen, verlof, kinderopvang, wonen en arbeidsvoorwaarden kunnen die ruimte vergroten of beperken.

6. Beperkingen en onderzoeksagenda

Huishoudens die minder werken verschillen mogelijk al in inkomen, gezondheid, opleiding, woonplaats en voorkeuren. Die factoren kunnen zowel de arbeidskeuze als de uitkomst verklaren. Causale claims vereisen longitudinale gegevens, geschikte controlegroepen, heldere uitkomstmaten en gevoeligheidsanalyses. De grootste praktische onzekerheid is de sectorale herallocatie.

Bronnen en methode

Zie SOURCES.md in de repository voor primaire startpunten bij CBS, UWV, RIVM, DNB, SCP, AZW en OCW. Zie docs/methodologie.md voor formules, aannames en verdere causaliteitswaarschuwingen.

© 2026 Patrick Bos. Beschikbaar onder Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).